

דגשים בטיפול במטופל STROKE במיון



סוכר



אישונים



פציאלים



חום

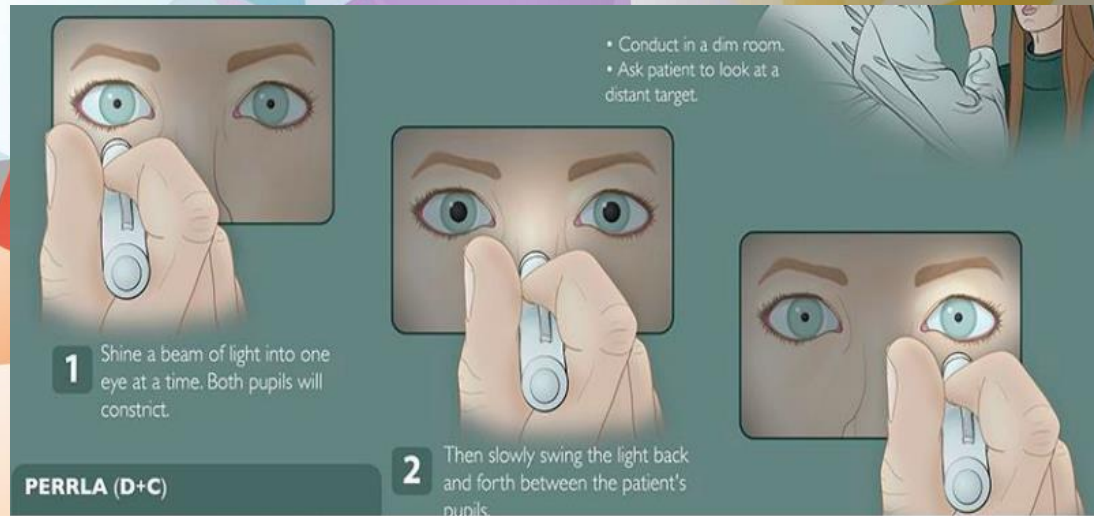
ועדכוני NIHSS



אישונים

אישונים תקינים הם עגולים ושווים, בגודל של 3 מ"מ.
בבדיקת אישונים נכוון מקור אור (פנס) על כל עין
בנפרד.

בדיקה תקינה- התגובה הישירה והבלתי ישירה של
האישונים תהיה שווה בשתיהן.



👁 מיוזיס

היצרות אישונים. פחות מ1 מ"מ.
גורמים-

1. דימום בגזע המוח
2. השפעה של מורפין או הרואין.
התגובה לאור תהיה תקינה

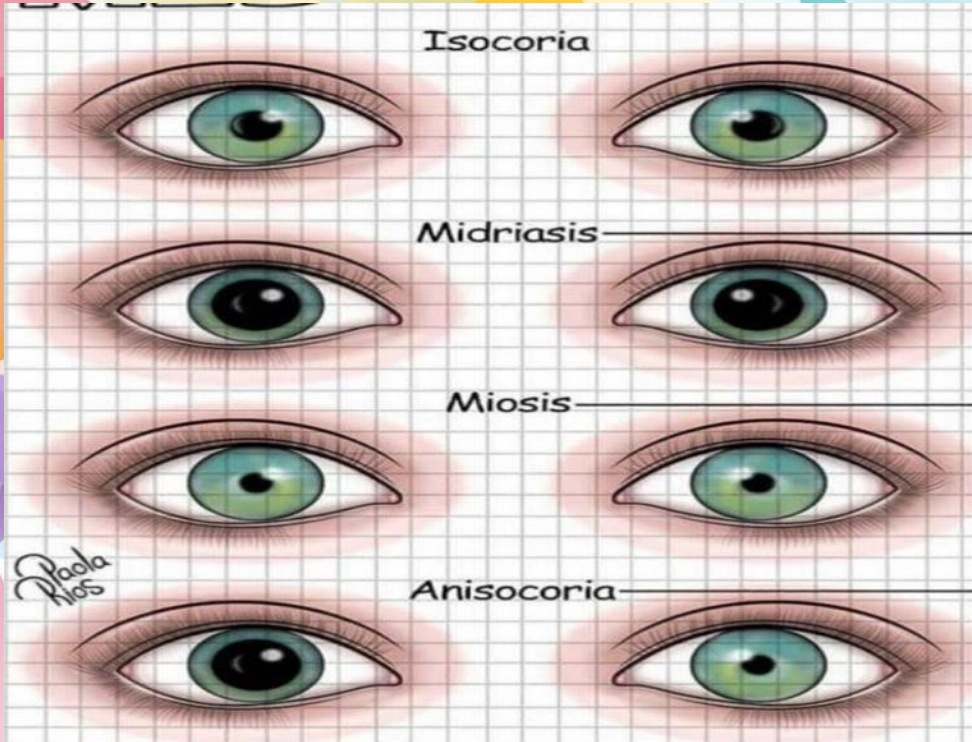
👁 מידריאזיס

הרחבת אישונים.
יש לסווג ל2 גורמים-

1. נטילת חומרים - קוקאין, אמפטמין וLSD
התגובה לאור תהיה תקינה וגודל האישונים יהיה 8-9 מ"מ

2. דימום, אוטם, גידול, פגיעת ראש מלווה בICP מוגבר,
התגובה לאור לא תהיה תקינה ונראה תגובה חד צדדית של
אישון

(לרוב באותו הצד של הדימום). גודלם יהיה 4-5 מ"מ



👁 אניזוקוריה

שונות בגודל האישונים.

יופיע באופן פיזיולוגי ברבע מהאוכלוסייה.

באופן פתולוגי- כתוצאה משיתוק עצבי, תרופות, מגרש

מבחינת תסמינים, היפוגליקמיה ומחלת חום מהוות אבחנה מבדלת לשבץ מוחי, לכן כל מטופל (גם אם אינו סכרתי) יש למדוד סוכר וחום בקבלה ולפחות פעם במשמרת.

במטופל מאובחן עם אירוע מוחי-



חום יכול להעיד על החמרה בשבץ\מצב זיהומי ובדומה להיפרגליקמיה יכול לגרום להחמרת האוטם\דימום\בצקת.



היפרגליקמיה נפוצה יותר בחולי שבץ. מהווה גורם סיכון להתרחבות האוטם ולהתמרה דימומית. לכן, יש לשמור על ערכי סוכר בין 140-180 ולטפל בהתאם במידת הצורך



היפוגליקמיה גורמת למוות הפנומברה (תאים בסביבת האוטם הסובלים מנזק מוגבל וניתן להצילם)

פציאלים

ללא חיוך

עם חיוך



נגרם בעקבות שיתוק עצב 7, לרוב נראה באוטם MCA שמאלי.

בדיקת פציאלים נעשית כחלק מבדיקות FAST וNIHSS.
שימו לב-

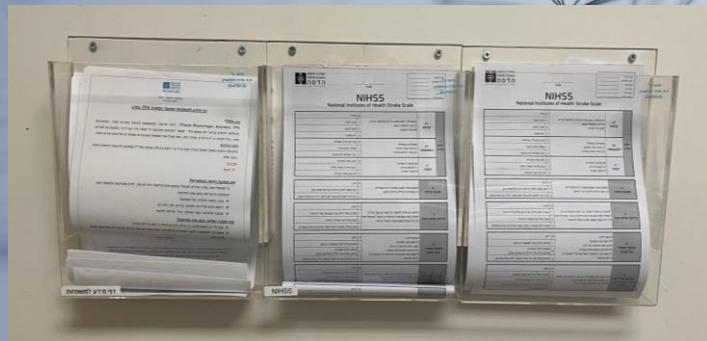
צריך לבקש מהמטופל לחייך על מנת לראות באופן מובהק את הפציאלים.

עדכוני NIHSS

זמני ביצוע האומדן

✓ **פעם במשמרת**
(לדוג'- מטופל התקבל במשמרת ערב, בוצע NIHSS ע"י הנוירולוג בקבלה. האחות שמגיעה במשמרת לילה צריכה לבצע את האומדן פעם אחת לאורך המשמרת)

✓ **החמרת המטופל**
(לדוג'- NIHSS בקבלה: ציון 2 בשל חולשת צד. לאחר כשעה במטופל מתלונן על קושי בדיבור- יש לעדכן את הנוירולוג ולבצע את האומדן)



דפי NIHSS תלויים בחדר
29- ניתן לבצע בעזרתם
את האומדן ולתייק בתיק
המטופל ←

תיעוד ביצוע האומדן

האומדן יבוצע **לראשונה** בקבלת המטופל ע"י **נוירולוג**.

באחריותנו:

✓ לשאול את הנוירולוג מהו הציון שהתקבל
✓ **לתעד את הציון במחשב בקבלה**
הסיעודית תחת הנושא "אנמנזה"
✓ **לכתוב בטופס הצהוב** את הציון שהתקבל
✓ **ליידע את האחות האחראית** ואת האחות המקבלת את האתר במשמרת הבאה מהו הציון.

A photograph of a yellow NIHSS-2 assessment form. The form has a header with "NIHSS-2" and "אירועים בימים האחרונים:". Below the header is a table with columns for "מצב המודינמי" and "מצב נשיני". The table contains several rows with checkboxes and handwritten marks. The checkboxes are labeled "לא יציב" and "יציב". The handwritten marks include "כן" and "לא". The form is titled "NIHSS-2" and "אירועים בימים האחרונים:". The table has columns for "מצב המודינמי" and "מצב נשיני". The rows are labeled "מונשם", "הכרה", "פצע לחץ", and "מיון". The checkboxes are labeled "לא יציב" and "יציב". The handwritten marks include "כן" and "לא".